

Entrepôt de Données de Santé du CHU

Dossier d'architecture et de traitements — pipeline ELT médaillon sur ClickHouse, restitution Metabase, automatisation tracée.

6 SOURCES	3 JOURS INGÉRÉS	14 864 SÉJOURS FIABLES	6 000 PATIENTS	8/8 CONTRÔLES VERIFY
---------------------	---------------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------------------------

1. Le besoin

Le CHU souhaite se doter d'un **Entrepôt de Données de Santé (EDS)**. Ses données sont aujourd'hui éparpillées dans plusieurs systèmes (dossier patient, urgences, laboratoire, monitoring des chambres) et exportées **chaque jour** sous forme de fichiers, dans des formats hétérogènes. La direction veut en tirer **deux usages** :

Public	Ce qu'il attend
Pilotage hospitalier	Durée Moyenne de Séjour par service, activité des urgences, taux de réadmission à 30 jours, relevés de constantes en alerte, charge par service
Recherche clinique	prévalence par pathologie (taille des cohortes), description de cohorte par âge et sexe

Les données de santé relèvent d'une **catégorie particulière** (RGPD, art. 9) : la conformité n'est pas une option mais une **contrainte de conception** présente à chaque étape. Les indicateurs doivent être **fiables, cohérents avec les sources et justifiables**.

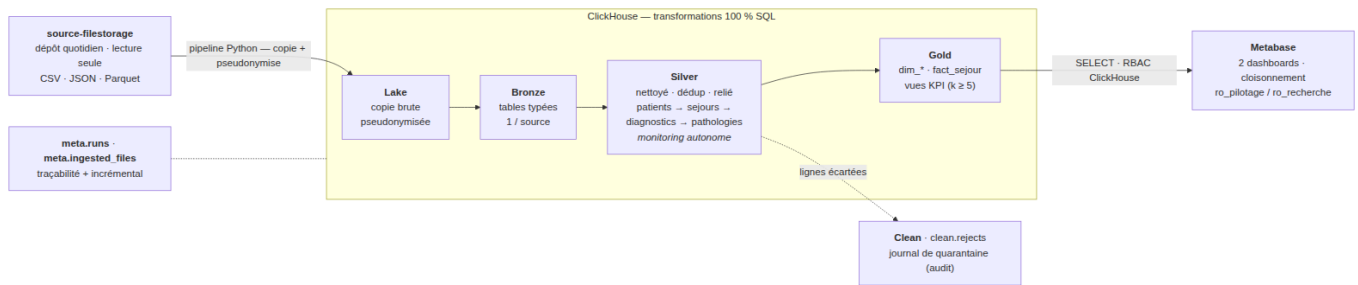
2. Les sources

Le CHU dépose chaque jour ses fichiers dans `source-filestorage/<source>/<AAAA-MM-JJ>/`, en **lecture seule**.
Volumétries constatées sur les 3 jours fournis (2026-08-26 à 28) :

Fichier	Format	Volumétrie	Particularité
patients.csv	CSV	4 801 / 5 401 / 6 001 lignes	contient l'identité réelle (NIR, nom, prénom) — à pseudonymiser
sejours.csv	CSV	5 001 lignes / jour	discharge_ts parfois vide = séjour en cours
diagnostics.json	JSON imbriqué	~1 Mo / jour	un ou plusieurs codes CIM-10 par séjour (principal / associé)
monitoring.parquet	Parquet	flux volumineux	constantes au chevet (FC, SpO2, température)
referentiels/services.csv	CSV	8 services	déposé le premier jour uniquement
referentiels/cim10.csv	CSV	10 codes	idem

Le même patient revient d'un jour à l'autre (retour quotidien du dossier) : 16 200 lignes patients brutes correspondent à **6 000 patients distincts**.

3. Architecture cible — schéma justifié



Architecture médaillon de l'EDS

Chaîne : *filestorage* → *lake* → *bronze* → *silver* → *gold* → *dashboards*, plus une étape *clean* (quarantaine). Python pilote, ClickHouse transforme.

Patron « médaillon » et ELT

On charge d'abord le **brut** (lake + bronze), puis on enchaîne les transformations dans l'entrepôt (silver, gold). Ce choix **ELT** (et non ETL) se justifie ici :

- le stockage ne coûte presque rien → on garde la source brute et on peut **rejouer** une transformation ou répondre à un nouveau besoin sans ré-extraire ;
- la **traçabilité** est native (on sait toujours d'où vient la donnée — utile RGPD / audit) ;
- l'entrepôt calcule à l'échelle, là où est la donnée.

Pourquoi ClickHouse

Critère	Apport pour ce projet
Stockage colonne	l'analytique agrège quelques colonnes sur des millions de lignes → ne lit que l'utile
Partitionnement (PARTITION BY toYYYYMMDD(ts) sur monitoring)	<i>partition pruning</i> : une requête par jour ne lit qu'une partition
Compression forte	le flux monitoring, le plus gros, tient sans difficulté
UI SQL intégrée (: 8123/play)	exploration et vérification immédiates
1 conteneur Docker	tourne sur un laptop, sans cluster

Principe : transformation *dans* le moteur

La transformation bronze → silver → gold s'exécute **en SQL, dans ClickHouse**. Python se contente de recopier les fichiers puis d'envoyer les requêtes. On ne sort jamais les données du moteur pour les traiter en mémoire (pandas) : c'est l'anti-pattern classique du Big Data — ça ne passe pas à l'échelle.

Rôle de chaque couche

Couche	Rôle unique	Support
Lake	copie brute, telle quelle (patients / séjours pseudonymisés)	fichiers data/lake/
Bronze	tables typées, peu transformées, 1 table par source	bronze.*
Clean	journal de quarantaine des lignes écartées — artefact opérationnel d'audit, non analytique (alimenté pendant l'étape silver)	clean.rejects
Silver	nettoyé, déduplicé, cohérent, relié : patients → séjours → diagnostics → pathologies ; monitoring = flux autonome	silver.*

Couche	Rôle unique	Support
Gold	indicateurs agrégés par usage (dims + fait = tables, KPI = vues)	gold.*

Flux

- **Entrant** : pipeline (Python) lit le filestorage en lecture seule et recopie vers le lake.
- **Interne** : Python envoie les fichiers sql/ à ClickHouse, couche par couche (bronze, clean, silver, gold).
- **Sortant** : Metabase lit gold.* via deux utilisateurs ClickHouse distincts (RBAC).
- **Transverse** : meta.runs (chaque exécution) et meta.ingested_files (idempotence).

Choix d'orchestration

Le dépôt est **quotidien** → traitement **batch**, simple et robuste. cron + Makefile suffisent : aucune infrastructure supplémentaire, rejouable, et une table de runs assure la traçabilité. Un orchestrateur (Airflow / Dagster) apporterait UI et *backfill* natifs mais serait disproportionné à cette échelle (cf. § 11).

4. Traitements & qualité

Pseudonymisation à l'entrée du lake (★ bonus)

Avant toute écriture dans le lake, pipeline/steps/1_lake.py applique :

Champ	Transformation
patient_id	patient_hash = sha256(PSEUDO_SALT + ":" + patient_id) tronqué — déterministe (jointures préservées) et non réversible
birth_date	→ birth_year (généralisation)
nir, nom, prenom	supprimés du fichier écrit
region_code	conservé (utile aux cohortes, non directement identifiant)

Le même hachage est appliqué à patient_id dans sejours.csv → le lien patient ↔ séjour est conservé. **Aucune donnée identifiante n'atteint le lake ni l'entrepôt.** Le sel vit dans .env, hors dépôt.

Contrôles qualité (silver) & journal de quarantaine (clean)

Principe imposé par le sujet : le traitement attendu est **simple** — on **écarte** les lignes fautives (et on déduplique les patients), **on trace** ce qu'on écarte dans clean.rejects (source, natural_key, rule, detail). Ce journal constitue une **étape clean distincte** de la base analytique silver : c'est un artefact opérationnel d'audit, pas une table d'analyse. Résultats sur le jeu fourni :

Source	Règle	Lignes écartées
monitoring	valeur hors plage physiologique (FC 20-250, SpO2 50-100, temp 30-45)	1 369
diagnostics	diagnostic rattaché à un séjour inconnu / écarté	340
sejours	discharge_ts < admission_ts (incohérence temporelle)	136
patients	sexe non normalisable · birth_year aberrant · durée > 180 j · service hors référentiel	0 (aucun cas sur ce jeu)

Bilan : **15 000** séjours bruts → **14 864** séjours fiables (99,1 %). **16 200** lignes patients → **6 000** patients (déduplication). Le fait gold.fact_sejour compte exactement 14 864 lignes (cf. contrôle de réconciliation, § 7).

5. Couche silver — modèle propre & décisions de nettoyage

Cette section explicite **pourquoi** chaque règle, et pourquoi « écarter » plutôt que « corriger ».

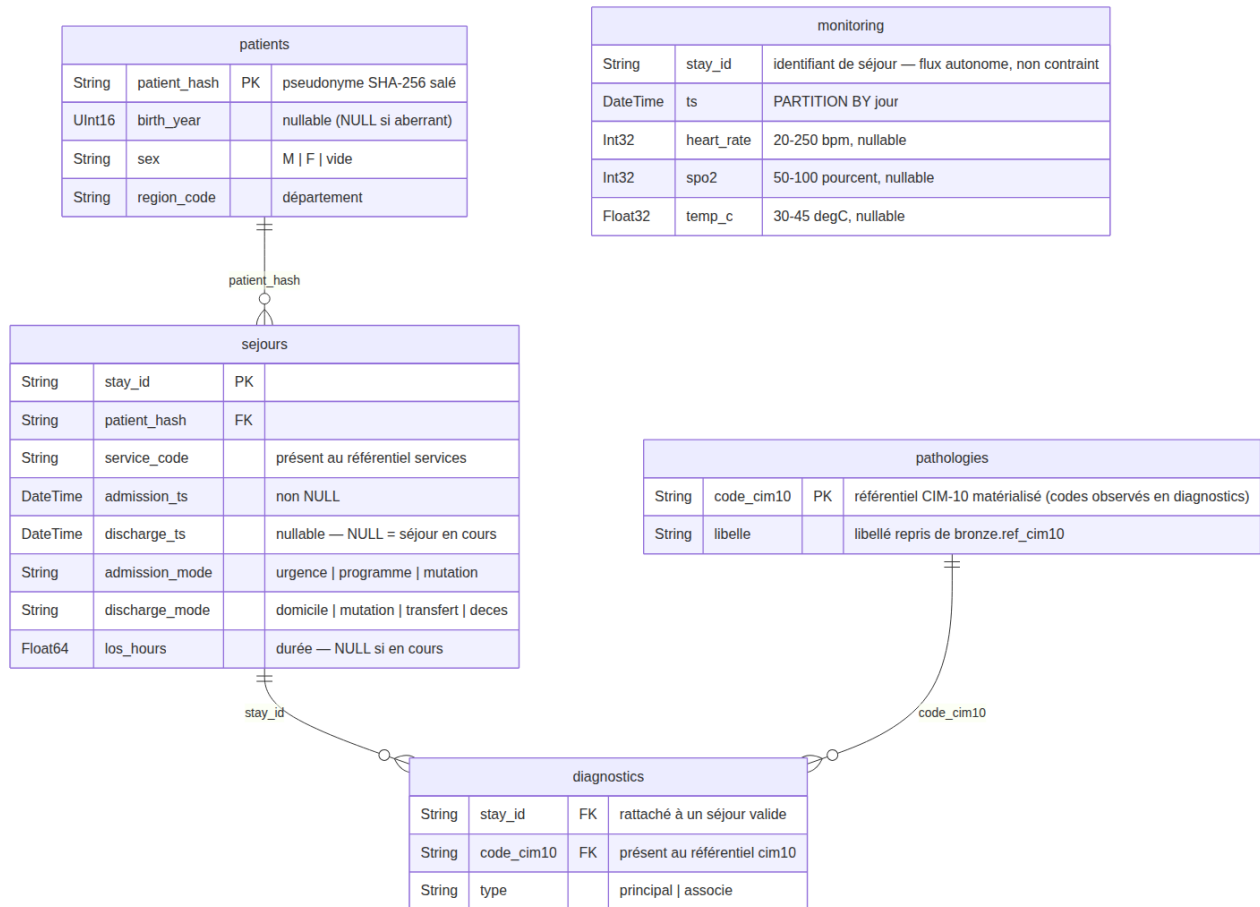


Schéma de la base silver

Base silver : une chaîne reliée patients → sejours → diagnostics → pathologies, plus le flux monitoring **autonome** (5 tables). Le journal des lignes écartées est **sorti de silver** — étape *clean* (§ 4). Les notes indiquent les bornes et l'intégrité référentielle appliquées.

Un rôle unique par couche

Silver **ne fait que** nettoyer / dédupliquer / relier : pas de typage (rôle du bronze), pas d'agrégation (rôle du gold). La traçabilité des lignes écartées est déportée dans l'étape *clean* (clean.rejects) — un journal opérationnel qui n'a pas sa place dans le modèle analytique. Cette séparation stricte rend le pipeline lisible et maintenable — on sait exactement où intervenir pour chaque type de problème.

Pourquoi cette chaîne — le grain suit la source

Le besoin métier est **centré patient** (prévalence par pathologie, cohortes), mais la donnée, elle, est produite au **grain du séjour** : diagnostics.json code chaque diagnostic sous un stay_id, jamais sous un patient_id (conforme au codage PMSI — le diagnostic appartient au résumé de séjour). On relie donc diagnostics à sejours, et non à patients, pour trois raisons :

- **Fidélité au grain** : un patient a plusieurs séjours, chacun avec son propre diagnostic principal (infarctus lors d'un séjour, BPCO six mois plus tard). Rattacher au patient obligerait à choisir arbitrairement « quel principal gagne » — on inventerait un grain absent de la source. Le type = 'principal' n'a de sens qu'**au séjour**.
- **Le besoin patient est déjà servi par jointure** : le patient_hash s'obtient via diagnostics.stay_id → sejours.stay_id → sejours.patient_hash. C'est ce chemin que matérialise gold.fact_sejour (qui porte à la fois patient_hash et diag_principal) et qu'exploite kpi_recherche_prevalence (uniqExact(patient_hash) par code). Une clé étrangère directe diagnostics → patients serait **redondante**.

- **Bénéfices de bord** : rattaché au séjour, un diagnostic hérite du filtre qualité (`INNER JOIN silver.sejours` → un diagnostic sur un séjour écarté est exclu) et de l'**ancrage temporel** (cohortes par période, lien avec la réadmission) — le patient n'a pas de date, le séjour a `admission_ts`.

Même logique pour `monitoring` : son grain est le relevé horodaté, indépendant du séjour → flux autonome (voir plus bas). Une vue « patient × pathologies » reste possible : c'est un *rollup* gold (`diagnostics` → `sejours` → patient), pas une relation de base.

Déduplication des patients — garder la version la plus récente

Le sujet l'impose. Implémentation : `argMax(colonne, business_date) GROUP BY patient_hash`.

- **Pourquoi** `business_date` (date du dépôt) et non l'horodatage technique d'ingestion : la date métier est la vérité ; l'horodatage technique peut varier selon l'ordre de traitement.
- **Pourquoi fusionner et non empiler les versions** : un patient est une **entité unique** dans l'entrepôt ; la jointure séjour → patient doit être 1-1, sinon les comptages de cohortes seraient faux.

Séjours — écarter `discharge_ts < admission_ts` (136 lignes)

On ne peut pas savoir **laquelle** des deux dates est fautive. Corriger serait arbitraire (et introduirait une donnée inventée, contraire à l'esprit RGPD). **Écarter + tracer** est auditable : 136 lignes, soit 2,7 % — impact quantifié et acceptable.

Séjours — conserver `discharge_ts NULL`

Explicitement « pas une anomalie » (patient encore hospitalisé). **Conséquence assumée** : la DMS et `los_hours` ne sont calculés que sur les **séjours clos** (`is_closed = 1`) ; les inclure biaiserait la durée à la baisse.

Monitoring — bornes physiologiques : écarter la ligne entière

Décision : dès qu'une constante renseignée est hors borne, on écarte **toute la ligne** (et non la seule valeur). Une valeur physiologiquement impossible signale une ligne corrompue (capteur, parsing) — on ne fait plus confiance aux autres colonnes de cette ligne. Un `NULL` est toléré (constante non mesurée à cet instant ≠ erreur).

Monitoring — flux autonome (pas de contrainte de séjour)

Le monitoring est un **flux de faits volumineux** (constantes au chevet) traité **indépendamment** de `silver.sejours` : la table n'est reliée à rien. Un relevé dont le `stay_id` est absent de `silver.sejours` (séjour écarté, ou identifiant erroné) est **conservé** — c'est de la télémétrie réelle, et aucun KPI ne joint monitoring aux séjours (`kpi_pilotage_alertes constantes` agrège par jour). Le refuser reviendrait à jeter des mesures physiologiques valides. Le taux d'orphelins est en revanche un **signal de qualité à remonter au CHU** (§ 11). Seules les bornes physiologiques restent appliquées.

Diagnostics — jointure stricte (340 rejets)

On ne garde que les diagnostics rattachés à un séjour `silver` **valide** et à un `code_cim10` **présent au référentiel**. Un diagnostic orphelin gonflerait artificiellement la prévalence d'une pathologie. Les codes conservés ici alimentent `silver.pathologies`.

Diagnostics → pathologies — le référentiel matérialisé dans le silver

`silver.pathologies` **découle des diagnostics** : ce sont les codes CIM-10 **réellement observés** dans `silver.diagnostics`, avec leur libellé canonique repris du référentiel bronze (source de vérité pour la *validation* des codes). La chaîne `diagnostics` → `pathologies` devient une vraie relation dans le modèle, `gold.dim_cim10` en découle, et un contrôle `verify (08)` garantit que tout code de `silver.diagnostics` est présent dans `silver.pathologies`, elle-même incluse dans le référentiel.

Normalisation du sexe — sans perdre le patient

multiIf sur les variantes (H, HOMME, MALE, FEMME...). Si la valeur reste irréductible → champ vide **tracé**, mais **le patient est conservé** : un sexe manquant n'invalide pas les autres analyses (minimisation de la perte d'information).

Contrôles ajoutés (exploration au-delà du sujet)

birth_year dans le futur ou < 1900 → année ramenée à NULL (cohorte « âge inconnu »), tracé ; service_code de séjour absent du référentiel → écarté ; durée de séjour > 180 j (sans être négative) → écartée, probable erreur de saisie. Aucun cas sur le jeu fourni, mais les contrôles sont en place et se déclencheront sur des dépôts réels.

Rebuild complet à chaque transform

Chaque couche fait TRUNCATE + INSERT depuis la couche amont — y compris clean.rejects, reconstruit à chaque run.

Choix idempotence > performance, assumé à l'échelle laptop : make transform est rejouable sans doublon. En production sur un vrai volume, on passerait à un traitement **incrémental par partition de date** et à un journal clean.rejects **historisé** (avec run_id).

6. Modélisation — schéma en étoile

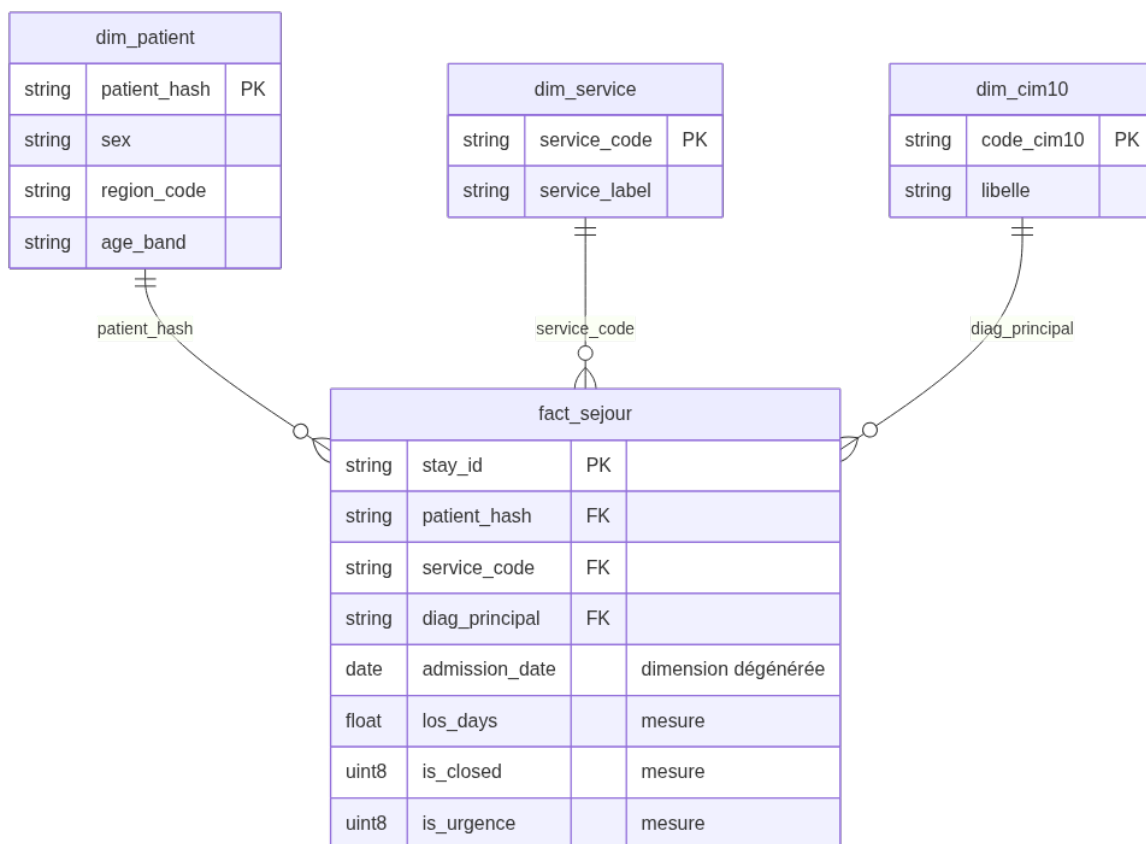


Schéma en étoile de la couche gold

- **Fait** : fact_sejour — 1 ligne = 1 séjour valide. Mesures : los_days, is_closed, is_urgence, comptages.
- **Dimensions** : dim_patient (sexe, région, tranche d'âge), dim_service (code → libellé), dim_cim10 (code → libellé, **alimentée par silver.pathologies**). La date d'admission est une **dimension dégénérée** portée par le fait.
- **Règle appliquée** : dans « KPI par X », X est une dimension et le KPI (compte / somme) sort du fait. On ne crée jamais de « fact_patient » — le patient n'est pas un événement.

7. Indicateurs — définitions et chiffres justifiés

Table de fait : `gold.fact_sejour`. Chaque chiffre est **reproductible** (`make verify`, § 10).

Pilotage

KPI	Définition	Valeur (jeu fourni)
DMS par service	<code>avg(los_days)</code> sur séjours clos, GROUP BY <code>service_code</code>	6,0 à 6,2 jours selon le service
Passages urgences / jour	<code>countIf(admission_mode = 'urgence')</code> par jour	≈ 1 676 / 1 721 / 1 627
Réadmission à 30 jours	part des sorties suivies d'une nouvelle admission du même <code>patient_hash</code> ≤ 30 j	5,34 %
Relevés en alerte / jour	relevés silver franchissant une borne d'alerte clinique (FC <40 ou >120, SpO2 <92, temp <35 ou >38,5)	quelques centaines / jour
Charge par service	admissions, séjours en cours, patients-jours cumulés	ONCO en tête (1 940 admissions)
Modes de sortie	répartition des <code>discharge_mode</code> (séjours clos)	domicile 42,5 % · décès 14,6 % · non renseigné 14,4 %

Recherche (k-anonymat : cohortes < 5 non diffusées)

KPI	Définition	Valeur
Prévalence par pathologie	<code>uniqExact(patient_hash)</code> par diagnostic principal, HAVING ≥ 5	I63 (AVC) 1 344 · J44 (BPCO) 1 327 · N39 1 325 · I21 (IDM) 1 320 · E11 (diabète) 1 316
Cohorte âge × sexe	nb patients par tranche d'âge × sexe, HAVING ≥ 5	réparti sur 5 tranches, ~370 à ~740 par cellule

Justification des chiffres

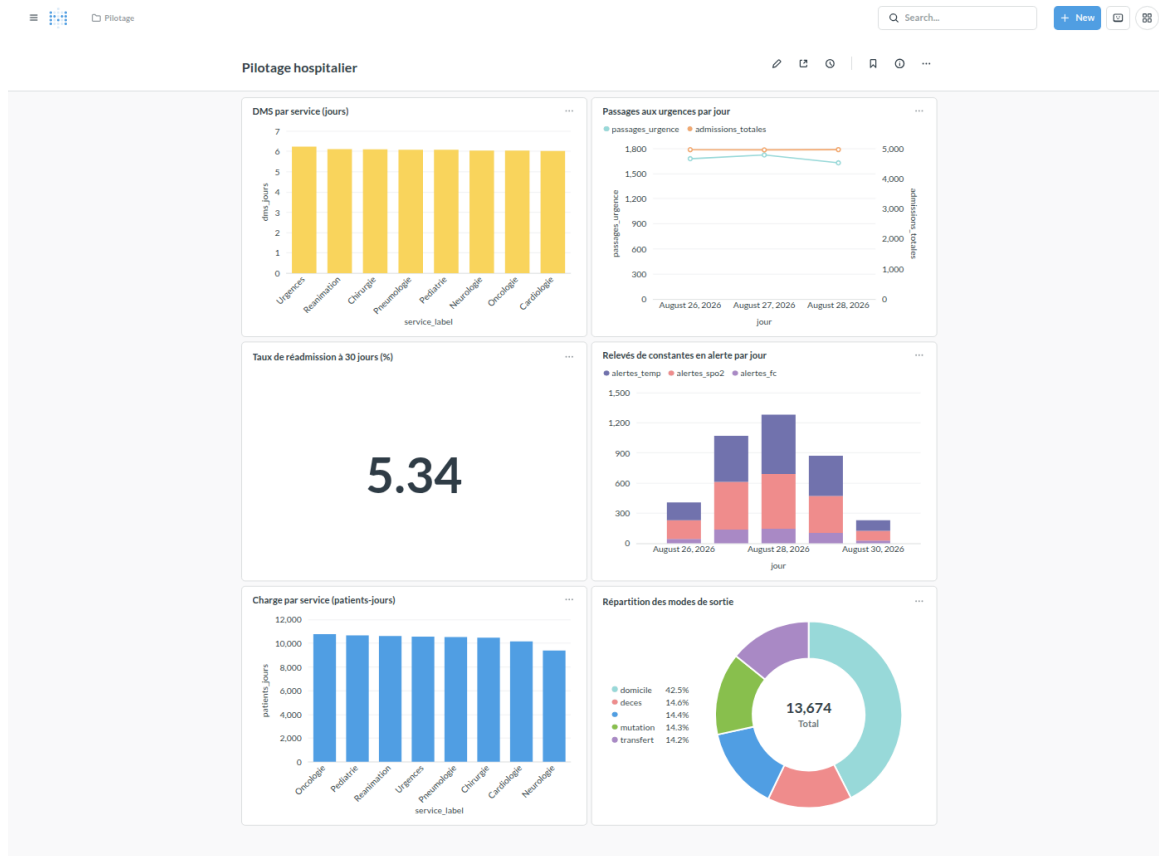
`make verify` exécute 8 contrôles de réconciliation qui **garantissent** ces valeurs :

- `count(gold.fact_sejour) = count(silver.sejours) = 14 864` ;
- tout `stay_id` de silver provient du bronze et n'a pas été écarté par ailleurs ;
- `count(patients distincts bronze) = count(silver.patients) = 6 000` ;
- aucune cohorte recherche < 5 ;
- aucun `los_hours` négatif, aucune incohérence temporelle résiduelle ;
- $\Sigma \text{ passages_urgence (KPI)} = \text{countIf(is_urgence)}$ sur le fait ;
- aucune constante hors plage résiduelle en silver ;
- tout `code_cim10` de `silver.diagnostics` est présent dans `silver.pathologies`, elle-même incluse dans le référentiel CIM-10.

8. Visualisations

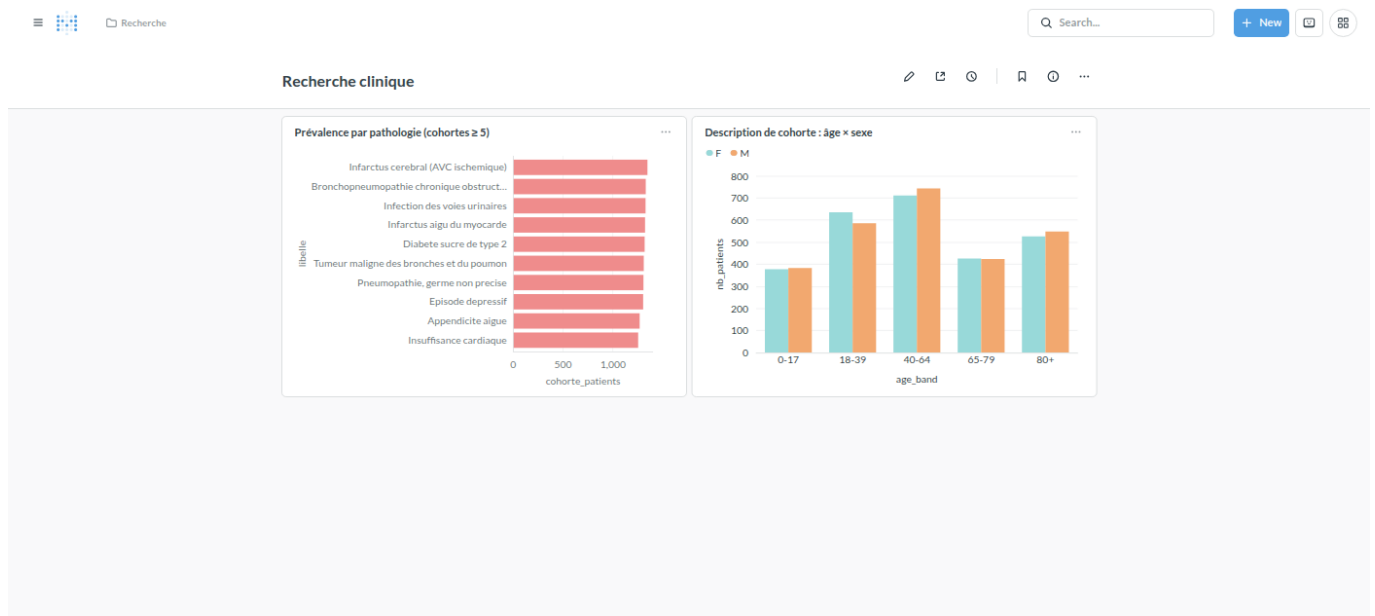
Deux dashboards Metabase provisionnés **automatiquement** et de façon idempotente par `make dashboards` (API REST, `pipeline/steps/4_dashboards.py`).

Dashboard « Pilotage hospitalier »



Dashboard Pilotage

Dashboard « Recherche clinique »

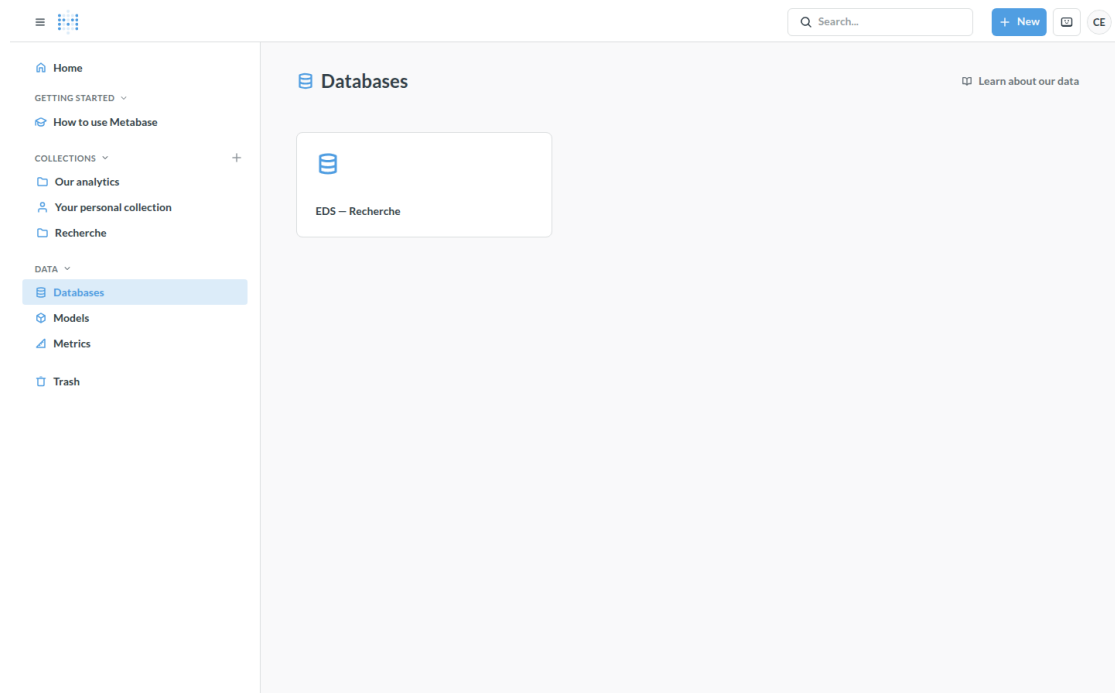


Dashboard Recherche

Démonstration du cloisonnement des droits

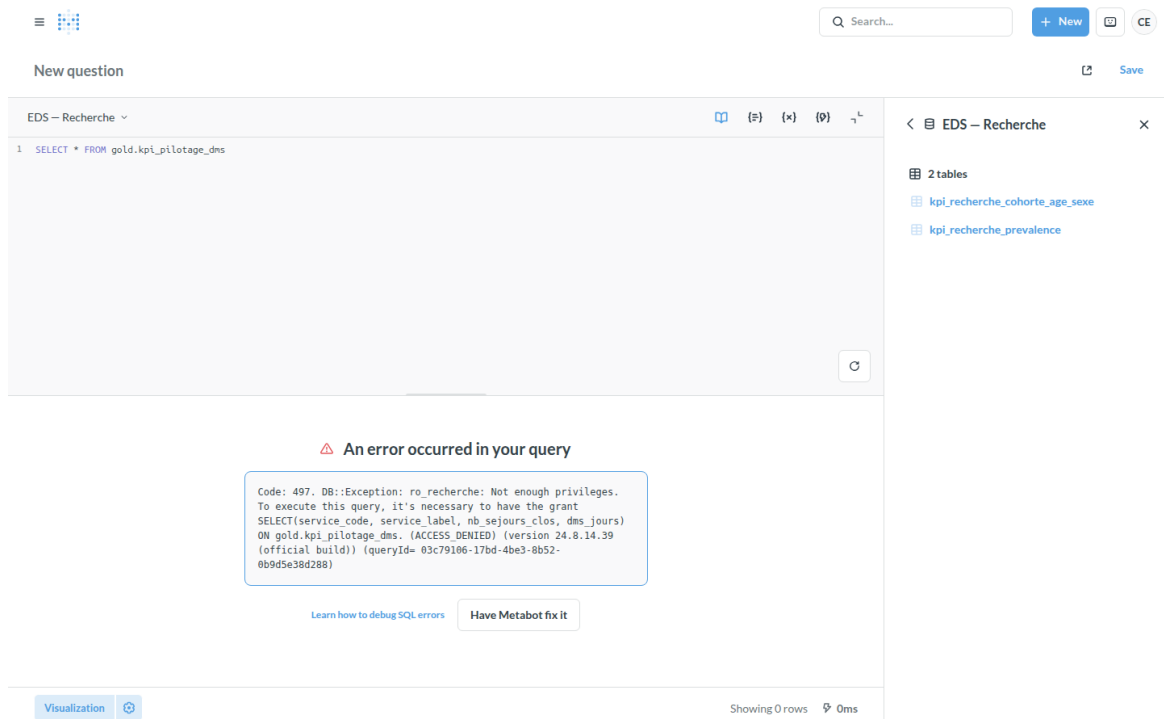
Le cloisonnement est porté à **deux niveaux**, le second étant la vraie garantie :

Niveau 1 — Metabase. Permissions de données et de collections par groupe. Un membre du groupe *Recherche* ne voit ni la base *EDS — Pilotage*, ni la collection / le dashboard *Pilotage*.



Vue d'un utilisateur Recherche

Niveau 2 — ClickHouse RBAC (la vraie garantie). `ro_recherche` n'a de `GRANT SELECT` que sur `gold.kpi_recherche_*`. Même en SQL libre via Metabase, une requête sur une vue de pilotage échoue.



Requête pilotage refusée pour ro_recherche

9. Gouvernance & RGPD

Contrainte	Mise en œuvre
Pseudonymisation	hachage salé déterministe à l'entrée du lake (§ 4) ; le <i>pipeline</i> n'écrit jamais d'identité réelle dans le lake ni l'entrepôt
Minimisation	nir/nom/prenom supprimés ; birth_date → année ; âge en tranches
Cloisonnement	2 utilisateurs ClickHouse (ro_pilotage, ro_recherche) + rôles ; 2 connexions et 2 groupes Metabase (§ 8)
Petits effectifs	HAVING ... ≥ 5 dans les vues gold.kpi_recherche_* ; contrôle verify associé
Traçabilité	meta.runs (qui, quand, quel statut) + meta.ingested_files (hash de chaque fichier) + logs horodatés ; clean.rejects journalise chaque ligne écartée (source, règle, clé)
Sécurité du sel	PSEUDO_SALT dans .env (jamais committé) ; sa perte casse les jointures historiques → sauvegarde hors dépôt

Le jeu de données utilisé ici est **synthétique** (fourni avec le sujet : noms et NIR fabriqués). En conditions réelles, le dépôt source-filestorage — qui contient l'identité en clair le temps du hachage — resterait **hors du dépôt Git** et hors périmètre de l'entrepôt.

10. Automatisation (Partie 2)

- **Incrémental & idempotent** : meta.ingested_files mémorise le hash de chaque fichier écrit → ré-exécuter ingest ne recopie rien de connu ; les transformations font un rebuild complet → transform rejouable sans doublon.
- **Commande quotidienne** : eds run-daily enchaîne ingest(jour) + transform + verify dans **un seul** meta.runs, avec code retour propre.
- **Planification** : crontab scripts/crontab.example — tous les jours à 02h15 ; sur échec, une ligne [ALERTE] est écrite dans logs/cron.log et le run est marqué error.
- **Journalisation** : logs/pipeline-AAAAMMJJ.log (console + fichier).
- **Reprise sur incident** : make status pour identifier le run en échec, corriger la cause, puis make replay DATE=<jour> (ré-ingère + rejoue les transformations).
- **Contrôle de fiabilité** : make verify — 8 contrôles, exit ≠ 0 si l'un casse ; branché sur run-daily et documenté dans .claude/skills/eds-run/SKILL.md.

11. Limites & recommandations

Alternatives écartées (et quand elles deviendraient pertinentes)

Piste	Écartée parce que	Basculer si...
dbt-clickhouse pour les transfos	on reste au plus près de la fiche-sujet (SQL + Python) et on limite les dépendances	le nombre de modèles SQL explose, besoin de tests et doc auto
Dagster / Airflow	lourd pour un laptop ; cron + meta.runs suffit à la démonstration	multiplication des sources, besoin de <i>backfill</i> et de dépendances complexes
Superset au lieu de Metabase	mise en place plus lourde ; le <i>row-level security</i> n'est pas nécessaire ici	besoin de filtrage fin par utilisateur au sein d'une même table

Passage à l'échelle du monitoring

Le flux monitoring est le plus volumineux et grossira. Le traiter comme un **flux autonome** (aucune jointure inter-tables à honorer au nettoyage) facilite ce passage à l'échelle. Recommandations : cluster ClickHouse (sharding par `stay_id`), politique de **rétenion** (TTL sur les partitions anciennes), **agrégats pré-calculés** (Materialized Views pour les alertes par jour) plutôt qu'un scan complet à chaque lecture.

Qualité & sécurité

- Étendre les contrôles silver (doublons de `stay_id` divergents entre dépôts, valeurs de `admission_mode` / `discharge_mode` hors nomenclature).
- `silver.monitoring` (flux autonome) contient des relevés dont le `stay_id` n'existe dans aucun séjour : **conservés** (télémétrie réelle), mais leur taux est à **remonter au CHU** comme anomalie de rattachement à la source — même logique que le `discharge_mode` non renseigné.
- Le référentiel `services` n'est pas (encore) matérialisé en silver comme pathologies : le retour portait sur la chaîne des diagnostics. Le promouvoir en `silver.services` rendrait la chaîne pleinement symétrique.
- Chiffrement au repos des volumes, journalisation des accès Metabase, rotation du sel de pseudonymisation avec table de correspondance sécurisée.
- Le champ `discharge_mode` est non renseigné sur ~14 % des séjours clos : à remonter au CHU comme problème **à la source**.